



EVCP 2017

Connaissances pratiques

Médecine générale

Cette annale contient

4 sujets · 16 questions

01 SUJET 1**VIGNETTE CLINIQUE**

Patient de 65 ans, retraité depuis quelques mois. Antécédents et facteurs de risque : surpoids, IMC à 29, tabagisme à 25 paquets/années interrompu il y a 10 ans, HTA traitée par Prazosine. La famille l'amène aux urgences car lors petit déjeuner (90 minutes plus tôt), il a présenté des troubles de l'élocution et a lâché son bol. Vous constatez qu'il est hémi-parétique à droite et aphasique.

1**QUESTION**

Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

2**QUESTION**

Quel examen complémentaire faut-il réaliser ?

3**QUESTION**

En l'absence d'hémorragie, quelle stratégie de prise en charge proposez-vous ? 4 La pression artérielle est alors à 155/85 mm Hg : que faites-vous ? 5 Pourquoi faut-il réaliser un ECG ? 6 Comment le résultat (de l'ECG) peut-il orienter votre prise en charge ?

7**QUESTION**

Vous le revoyez en consultation un mois plus tard. Il a toujours le même traitement. Sa pression artérielle est à 155/85 (confirmée par auto-mesures). Que proposez-vous ? TSVP

02 SUJET 2**VIGNETTE CLINIQUE**

Vous recevez aux Urgences Mr G, 85 ans, adressé pour chute au domicile. Son aide ménagère a appelé les pompiers en le découvrant au sol dans ses toilettes, ce matin. Constantes à l'arrivée : TA 105/65 mmHg, pouls 110 BPM, température auriculaire 37,5, Saturation 92% (air ambiant). Il est désorienté sans signe méningé ni de localisation neurologique. L'électro-cardiogramme est normal hormis une tachycardie sinusale. Vous contactez son médecin traitant qui vous détaille ses antécédents : Ethylo-tabagisme chronique HTA- Dépression Ainsi que ses traitements : Perindopril 4mg/j - Nicardipine 50 mg/12h Hydrochlorothiazide 25mg/j (ajout récent en raison d'une HTA insuffisamment contrôlée.) Paroxétine 20mg/j Bromazepam 6mg/j Aspirine 75MG/j

1 QUESTION
Quelles sont les 3 principales causes de chute à évoquer chez ce patient?

2 QUESTION
Il n'a pas pu se relever seul. Vous notez une ecchymose frontale et il ressent une douleur fessière. Quel(s) examen(s) d'imagerie demandez-vous ?

Réponses proposées :
Justifiez.

3 QUESTION
Le patient continue à présenter des troubles cognitifs malgré la normalité des examens d'imagerie. Suggérez 2 éléments à vérifier à l'examen clinique.

4 QUESTION
Voici ses premiers résultats biologiques : Leucocytes $9,8 \times 10^9/L$ – Hémoglobine 9,4g/dl VGM 75 fl Globules rouges $3,5.10^{12}/L$ Plaquettes $350.10^9/L$ Sodium 120 mmol Potassium 4,8 mmol Chlore 87 mmol Bicarbonates 24 mmol Urée 15 mmol Créatinine 212 $\mu mol/L$ Glucose 5,5 mmol Calcium 2,2 mmol Protides 65 g/L CPK 5200 U/L. Quelles anomalies significatives identifiez-vous TSVP

5 QUESTION
Quelles sont les causes possibles de l'anomalie du ionogramme sanguin ?
Le patient est hospitalisé en service de médecine pour rééquilibration hydro-électrolytique. Quelle(s) classe(s) médicamenteuse(s) utilisez-vous pour l'anticoagulation prophylactique ?
Après 3 jours d'hospitalisation, l'infirmière vous signale avoir découvert un mélema dans le lit du patient. À la gastroscopie, quelles sont les 3 anomalies que vous vous attendez à observer de façon la plus probable ?

03 SUJET 3

VIGNETTE CLINIQUE

Un homme de 70 ans se plaint d'une douleur d'apparition brutale de la base thoracique gauche associée à une dyspnée. Dans les antécédents on note une hypertension artérielle bien équilibrée sous amlodipine, un diabète de type 2 traité par sulfamides hypoglycémisants, un polype colique réséqué et une gonarthrose. Il existe un tabagisme actif. L'examen clinique montre une température à 38,0 °C, une fréquence cardiaque régulière à 95/min, une saturation en oxygène au doigt à 92% (en air ambiant) et une tension artérielle à 154/91 mmHg.

QUESTION**1**

Quelles sont les 3 hypothèses diagnostiques que vous devez évoquer ? Dans l'hypothèse d'une embolie pulmonaire, quel examen permet de confirmer ce diagnostic ? L'embolie pulmonaire est confirmée. Quel bilan pré-thérapeutique prescrivez-vous ?

QUESTION**4**

Dans l'hypothèse où le bilan pré-thérapeutique est normal, quel type de traitement anticoagulant prescrivez-vous d'emblée ?

QUESTION**5**

Dans l'hypothèse où l'hémogramme montre un taux d'hémoglobine de 9,7 g/dl avec un VGM à 74 fl. Quels éléments d'interrogatoire cherchez-vous compte tenu de ce résultat ? Dans ce contexte d'anémie microcytaire, quel est le diagnostic le plus probable ?

Réponses proposées :

Quel examen demandez-vous pour le confirmer ?

04**SUJET 4****VIGNETTE CLINIQUE**

Un homme de 45 ans est amené aux urgences par les pompiers suite à une chute sur la voie publique. Il présente une plaie du scalp. On note plusieurs passages aux urgences cette année dans des circonstances identiques. Il a comme ATCD des séjours en hospitalisation psychiatrique et un traitement injectable retard mensuel halopéridol* 4 ampoules, administré en centre médico-psychologique. Il est actuellement au chômage. Il vit en foyer d'hébergement d'urgence. A son arrivée, on retrouve une plaie du cuir chevelu de 5 cm ; il est logorrhéique, et tient des propos familiers. La pression artérielle est de 130/80 mm, le pouls est à 90/min, la température à 37,6. La saturation en oxygène de 96%. L'éthylomètre pratiqué est de 0.8 en air expiré.

QUESTION

1

Six heures après son admission aux urgences, l'infirmière vous appelle pour une crise convulsive, en phase de récupération. A ce stade, que demandez-vous comme investigations indispensables sachant que votre examen clinique est normal TSVP

QUESTION

2

Les examens complémentaires sont normaux. Quelques heures plus tard, le patient s'agite, hurle, dit qu'il voit son chien aboyer dans la pièce et qu'il faut lui donner à manger. La température est de 38,6, le pouls à 120/min, la tension artérielle à 180/120. L'examen clinique est toujours sans particularités. Quels sont les principaux diagnostics à poser : Que prescrivez-vous comme traitement en première intention : Le diagnostic de Gayet Wernicke est posé chez ce patient dans les suites de l'hospitalisation. Quelles sont les trois principaux signes cliniques qui évoquent ce diagnostic ?

QUESTION

3

Quel est le traitement à préconiser dans le syndrome de Gayet Wernicke ?

QUESTION

4

a/ En l'absence de traitement, quelle peut être l'évolution à terme de ce syndrome ?

Réponses proposées :

b/ Quels en sont les trois principaux signes cliniques

FILENAME \p G:\Pae\2017\Spec.71
Médecine générale\EVCP.71.DOC Page NUMPAGES nvcvVLvcv h-gY h6uñ háy9 gda
gd6uñ ~v~n~n h,l| gdáy9 h[tO gd,l| gdQ# sÄÄ hQ# h~ZU tj`U hH5z gdàVÎ umim h.4Z
hàVÎ gdTe8 gdÇ) hãA^ UÔhdP òùOh ODONTOLOGIE `zÿ% àz[,9Ó sù69Ó Prodiser Titre
Document Microsoft Word MSWordDoc Word.Document.8